

La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Page de titre	Présentation des données (1/2)	Présentation des données (2/2)	Problématique et axes d'analyse	Panorama des troubles mentaux	Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et ..
---------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------

Santé mentale dans le monde Facteurs socio-économiques et prévalence des troubles mentaux (2013-2023)

Clara DUBOST et Sirine DAKHLI - IDIA2026

La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Page de titre	Présentation des données (1/2)	Présentation des données (2/2)	Problématique et axes d'analyse	Panorama des troubles mentaux	Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et ..
---------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------

Description des jeux de données

1. IHME - Global Burden of Disease (2023)

- Pays (country_fr) : qualitative nominale, 204 modalités ;
- Continent : qualitative nominale, 6 modalités ;
- Sexe (sex_fr) : qualitative nominale, 2 modalités : Homme, Femme ;
- Trouble mental (disorder_fr) : qualitative nominale, 7 modalités ;
- Année (year) : quantitative discrète, 2013 à 2023 ;
- Prévalence (prevalence_pct) : quantitative continue, en %.

2. World Bank - PIB par habitant

- Pays : qualitative nominale ;
- Année : quantitative discrète ;
- PIB par habitant (gdp_per_capita) : quantitative continue, en USD.

3. World Bank - Dépenses de santé

- Pays : qualitative nominale ;
- Année : quantitative discrète ;
- Dépenses de santé (health_expenditure_pct_gdp) : quantitative continue, en % du PIB.

4. World Bank - Population urbaine

- Pays : qualitative nominale ;
- Année : quantitative discrète ;
- Population urbaine (urban_population_pct) : quantitative continue, en %.

La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Page de titre	Présentation des données (1/2)	Présentation des données (2/2)	Problématique et axes d'analyse	Panorama des troubles mentaux	Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et ..
---------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------

Description des jeux de données

5. UNDP - Indice de Développement Humain

- Pays : qualitative nominale ;
- IDH (hdi_value) : quantitative continue, score de 0 à 1 ;
- Catégorie IDH (hdi_category_fr) : qualitative ordinale, 4 niveaux : Faible, Moyen, Élevé, Très élevé.

6. UNDP - Indice d'Inégalité de Genre

- Pays : qualitative nominale ;
- GII (gii_value) : quantitative continue, score de 0 à 1.

7. World Bank - Classification des revenus μ

- Pays : qualitative nominale ;
- Année : quantitative discrète ;
- Catégorie de revenu (income_group_fr) : qualitative ordinale, 4 niveaux : Revenu faible, intermédiaire inférieur, intermédiaire supérieur, élevé.

Périmètre total : 204 pays, 2013-2023, 31 416 observations après nettoyage et jointure.

..

La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Page de titre	Présentation des données (1/2)	Présentation des données (2/2)	Problématique et axes d'analyse	Panorama des troubles mentaux	Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et dépression
---------------	--------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Problématique : Quels facteurs socio-économiques influencent la prévalence des troubles mentaux dans le monde ?

Quatre axes d'analyse :

Axe 1 - Richesse et développement

La richesse protège-t-elle contre la dépression ? Le niveau de développement humain joue-t-il un rôle ?

Axe 2 - Genre et inégalités

Les femmes sont-elles plus touchées ? L'inégalité de genre influence-t-elle le diagnostic ?

Axe 3 - Santé et urbanisation

Les dépenses de santé réduisent-elles la prévalence ? La vie en ville est-elle un facteur de risque ?

Axe 4 - Évolution temporelle et COVID-19

Comment la pandémie a-t-elle impacté la santé mentale selon le genre et les continents ?

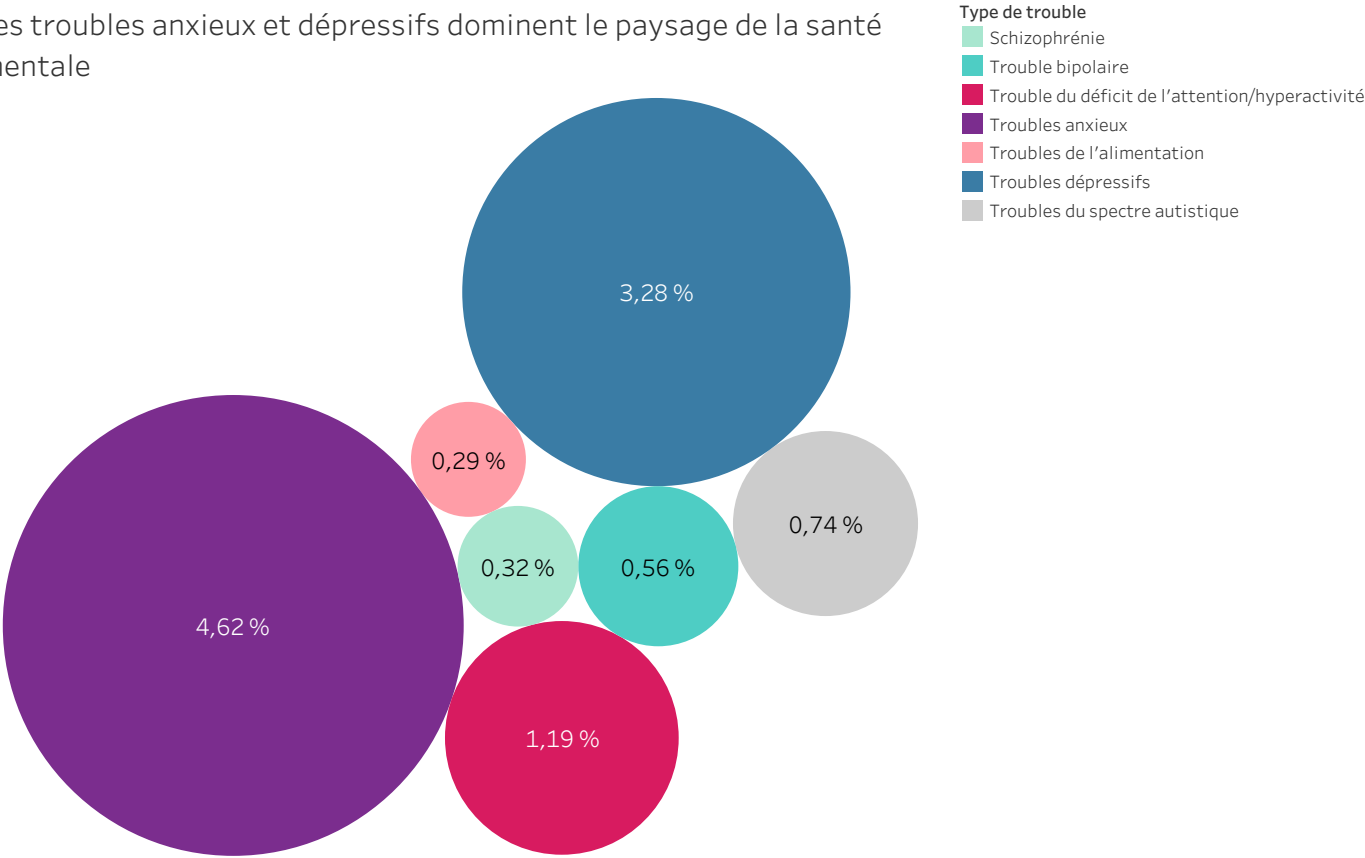
..

La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Présentation des données (1/2)	Présentation des données (2/2)	Problématique et axes d'analyse	Panorama des troubles mentaux	Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et dépression	Axe 1 - Richesse et tous les troubles
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Plus de 10% de la population mondiale souffre d'un trouble mental. Parmi les 7 catégories étudiées, les troubles anxieux (4,62 %) et dépressifs (3,28 %) dominent largement, représentant à eux seuls près de 70 % des cas. Les autres troubles (TDAH, autisme, schizophrénie, troubles bipolaires et alimentaires) touchent chacun moins de 1,2 % de la population.

Les troubles anxieux et dépressifs dominent le paysage de la santé mentale

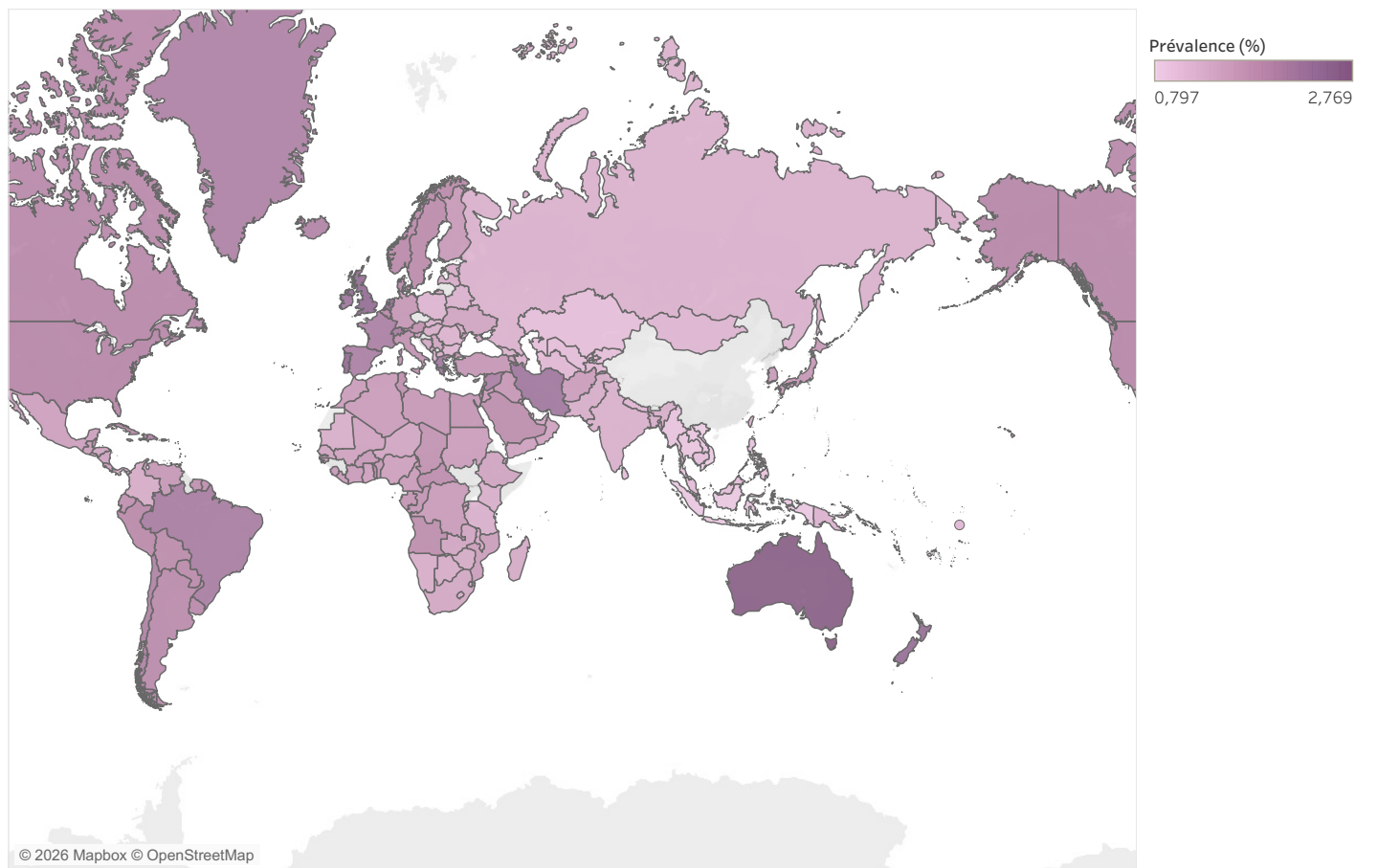


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Présentation des données (2/2)	Problématique et axes d'analyse	Panorama des troubles mentaux	Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et dépression	Axe 1 - Richesse et tous les troubles	Axe 1 - Prévalence par revenu
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

La santé mentale ne connaît pas de frontières, mais certaines régions sont plus touchées que d'autres. Sélectionnez un trouble pour explorer sa répartition géographique. Pour la dépression, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Ouest présentent les taux les plus élevés.

Géographie des troubles mentaux dans le monde (2019)

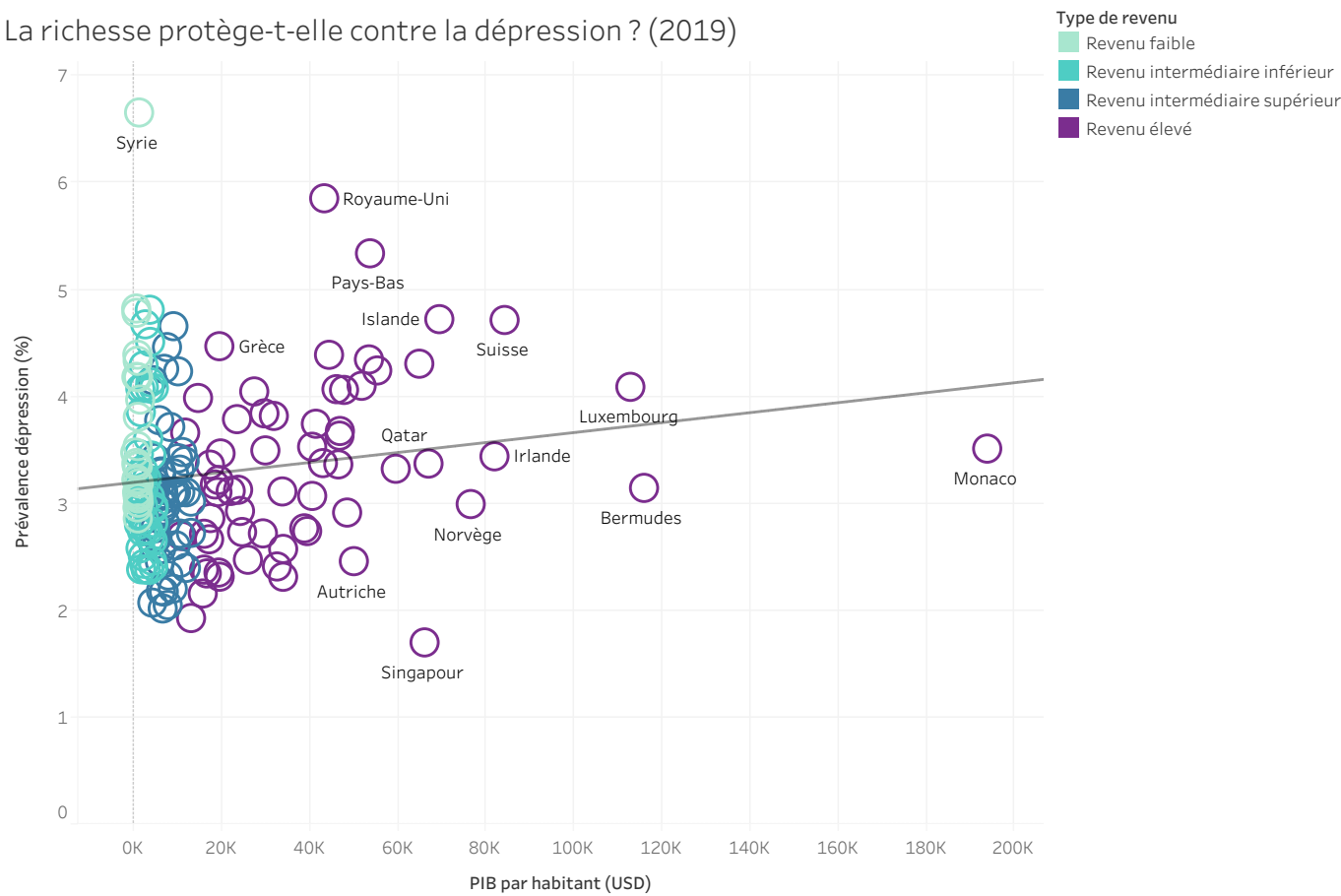


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Problématique et axes d'analyse	Panorama des troubles mentaux	Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et dépression	Axe 1 - Richesse et tous les troubles	Axe 1 - Prévalence par revenu	Axe 1 - Prévalence par IDH
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

On pourrait penser que les pays riches sont épargnés. En réalité, c'est l'inverse : la ligne de tendance montre une légère corrélation positive entre PIB et prévalence. Les pays à revenu élevé, comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, affichent des taux parmi les plus hauts. Ce paradoxe s'explique probablement par un meilleur accès au diagnostic dans les pays riches.

La richesse protège-t-elle contre la dépression ? (2019)

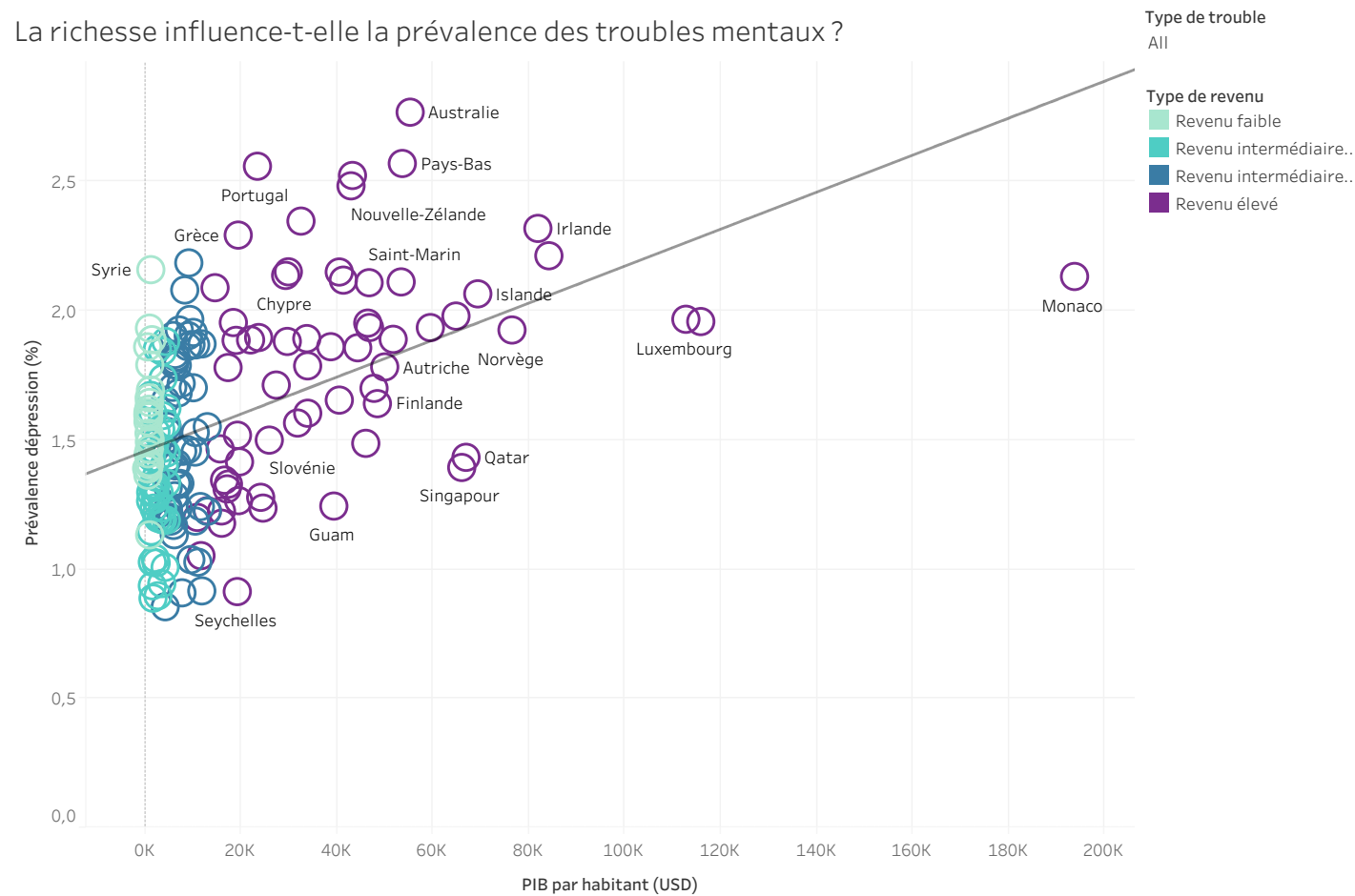


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Panorama des troubles mentaux	Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et dépression	Axe 1 - Richesse et tous les troubles	Axe 1 - Prévalence par revenu	Axe 1 - Prévalence par IDH	Axe 2 - Écart homme/femme
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------

Ce constat ne se limite pas à la dépression. Sélectionnez un trouble pour vérifier : quel que soit la pathologie, la richesse n'apparaît pas comme un facteur protecteur. Pour certains troubles comme l'anxiété, la tendance positive est encore plus marquée.

La richesse influence-t-elle la prévalence des troubles mentaux ?

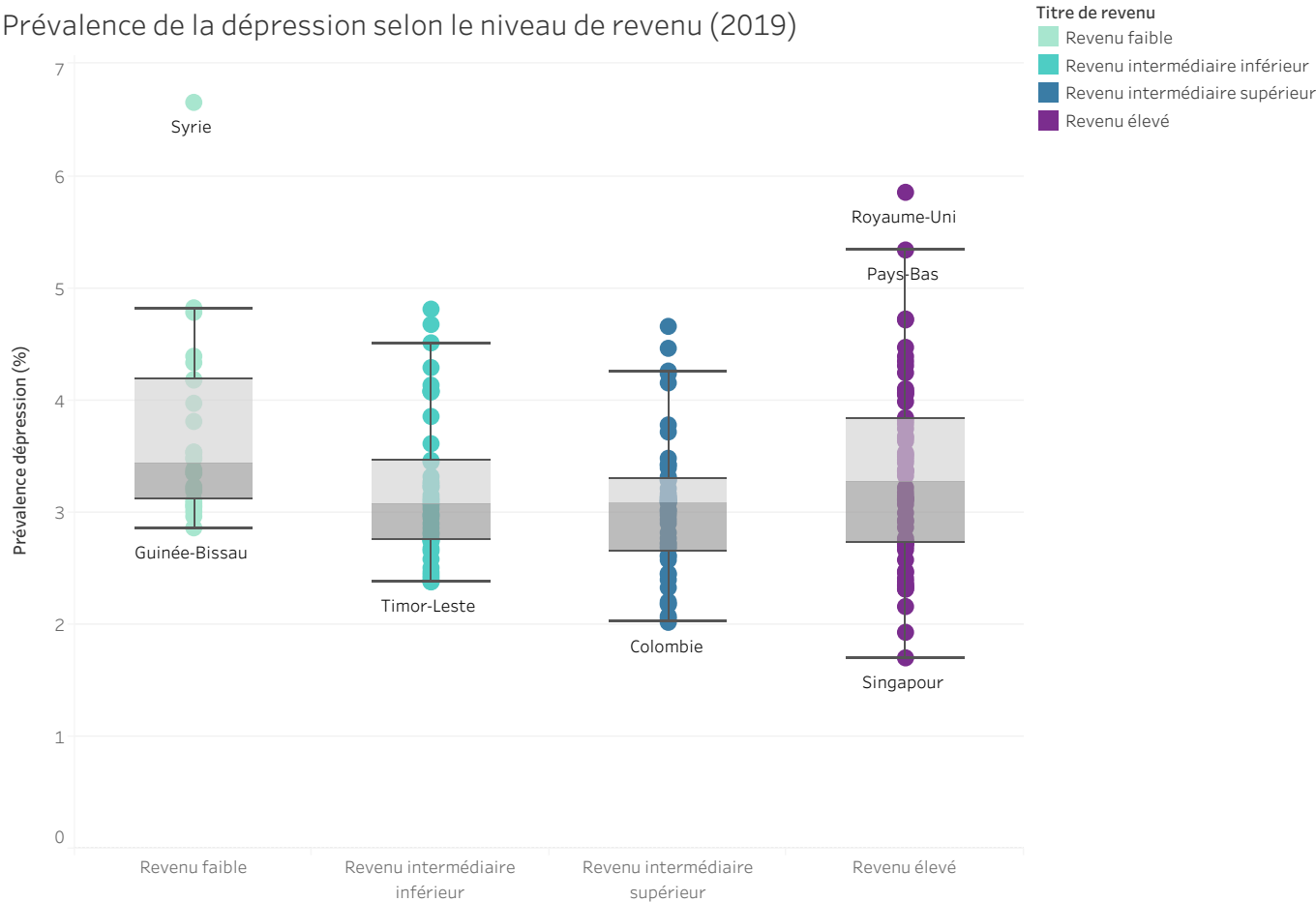


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Géographie des troubles mentaux	Axe 1 - Richesse et dépression	Axe 1 - Richesse et tous les troubles	Axe 1 - Prévalence par revenu	Axe 1 - Prévalence par IDH	Axe 2 - Écart homme/femme	Axe 2 - Inégalité de genre et diagnostic
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--

Riche ou pauvre, la dépression frappe partout. Les médianes sont proches quel que soit le niveau de revenu (~3,3 %). En revanche, les pays à revenu élevé montrent la plus grande variabilité : de Singapour (1,7 %) au Royaume-Uni (5,8 %), les écarts sont considérables au sein d’une même catégorie économique.

Prévalence de la dépression selon le niveau de revenu (2019)

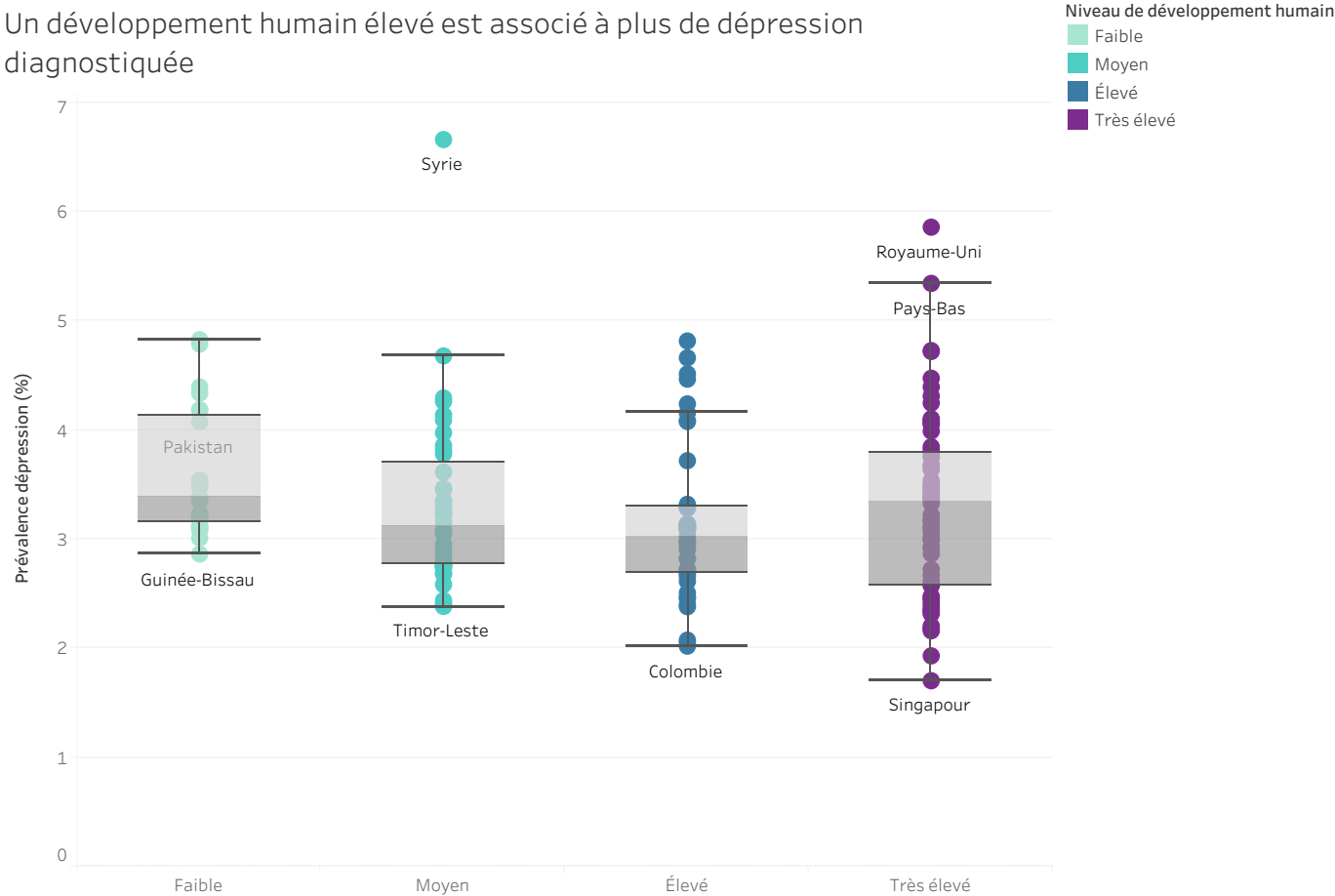


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 1 - Richesse et dépression	Axe 1 - Richesse et tous les troubles	Axe 1 - Prévalence par revenu	Axe 1 - Prévalence par IDH	Axe 2 - Écart homme/femme	Axe 2 - Inégalité de genre et diagnostic	Axe 3 - Dépenses de santé
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--	---------------------------

Les pays très développés présentent la plus grande dispersion des taux de dépression. Plus un pays est développé, mieux il détecte et diagnostique la dépression, ce qui gonfle les statistiques. Le développement humain ne cause pas la dépression : il la rend visible.

Un développement humain élevé est associé à plus de dépression diagnostiquée



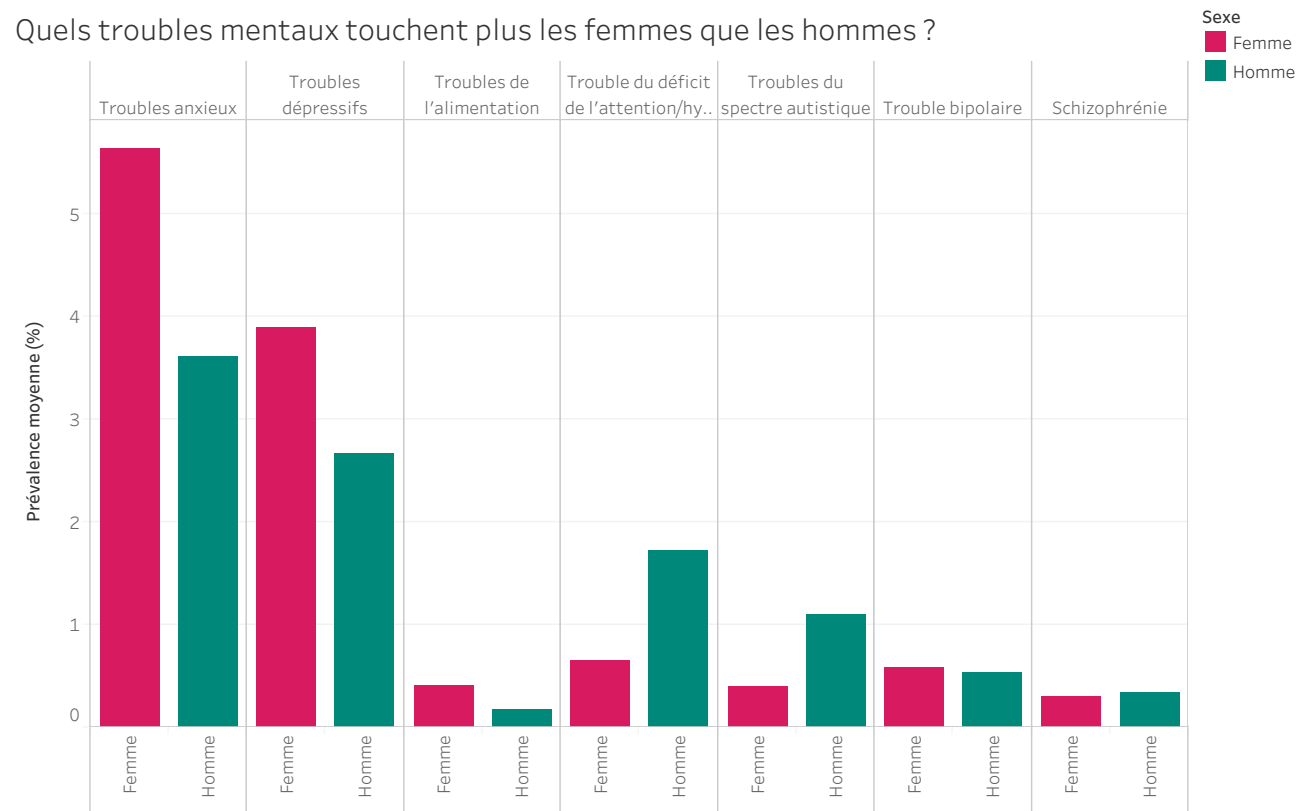
La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 1 - Richesse et tous les troub..	Axe 1 - Prévalence par revenu	Axe 1 - Prévalence par IDH	Axe 2 - Écart homme/femme	Axe 2 - Inégalité de genre et diagnostic	Axe 3 - Dépenses de santé	Axe 3 - Urbanisation
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--	---------------------------	----------------------

Tous les individus ne sont pas égaux face aux troubles mentaux. Les femmes sont presque deux fois plus touchées par l’anxiété et la dépression que les hommes. À l’inverse, les hommes sont davantage diagnostiqués pour le TDAH et les troubles du spectre autistique.

Ces écarts reflètent à la fois des différences biologiques (hormonales, génétiques) et des biais de diagnostic. Au-delà des différences biologiques, un biais culturel important existe : dans de nombreuses sociétés, les normes masculines (force, stoïcisme) découragent les hommes de consulter et d’exprimer leur souffrance psychologique. Les hommes sont donc probablement sous-diagnostiqués, ce qui gonfle artificiellement l’écart avec les femmes.

Quels troubles mentaux touchent plus les femmes que les hommes ?

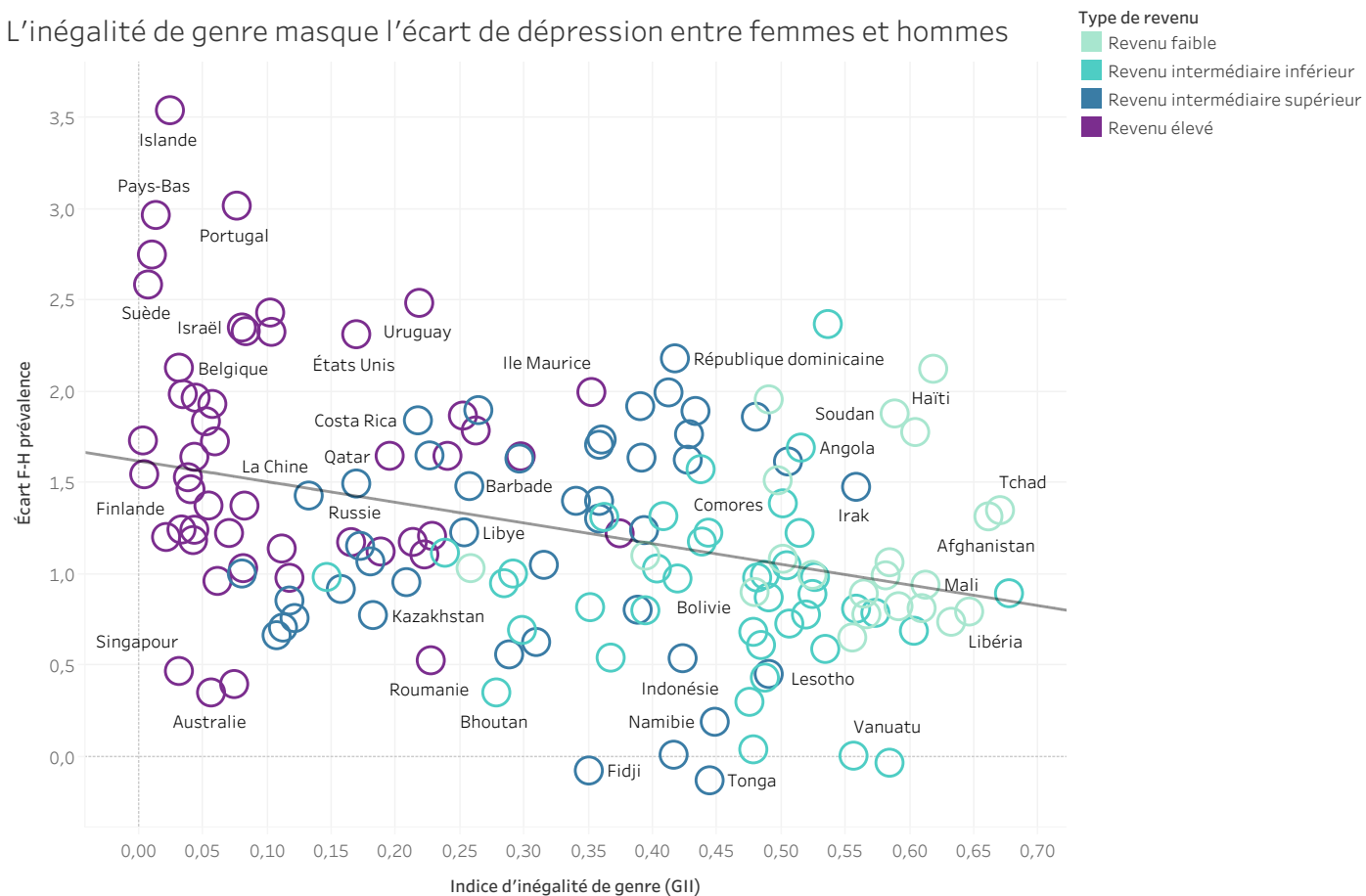


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 1 - Prévalence par revenu	Axe 1 - Prévalence par IDH	Axe 2 - Écart homme/femme	Axe 2 - Inégalité de genre et diagnostic	Axe 3 - Dépenses de santé	Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--	---------------------------	----------------------	------------------------------

Plus un pays est inégalitaire envers les femmes (indice GII élevé), plus l'écart de dépression entre les sexes diminue. Paradoxalement, ce n'est pas que les femmes vont mieux dans ces pays : c'est qu'elles y sont moins diagnostiquées. L'égalité de genre améliore l'accès au soin et rend les écarts réels visibles.

L'inégalité de genre masque l'écart de dépression entre femmes et hommes

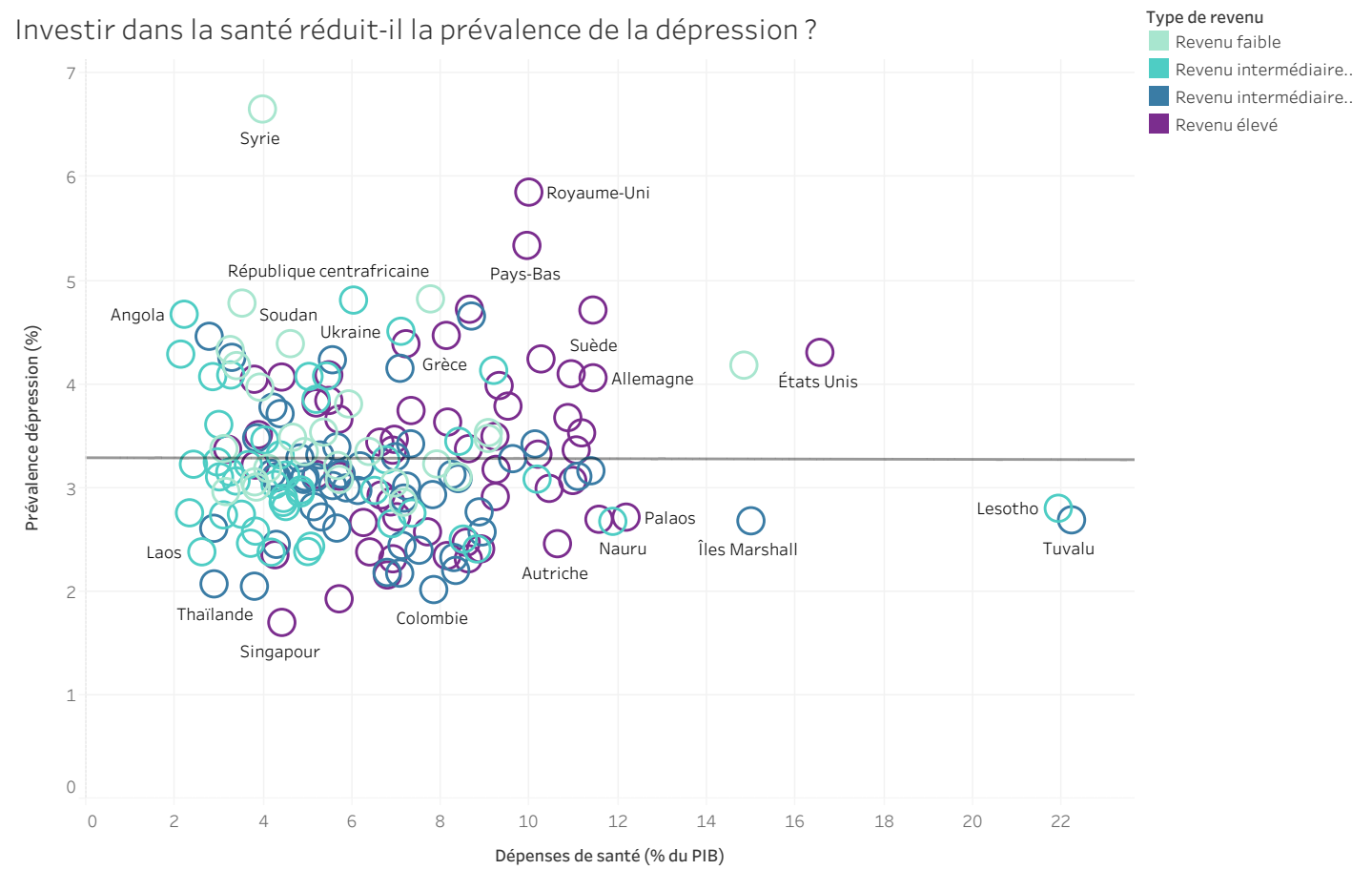


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 1 - Prévalence par IDH	Axe 2 - Écart homme/femme	Axe 2 - Inégalité de genre et diagnostic	Axe 3 - Dépenses de santé	Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle	Axe 4 - Impact du COVID par genre
----------------------------	---------------------------	--	---------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------------

Investir davantage dans la santé ne réduit pas automatiquement la dépression. La ligne de tendance est quasi plate : le volume des dépenses n’a pas d’impact clair. C’est la qualité et le ciblage des dépenses qui comptent : investir spécifiquement dans la santé mentale pourrait faire la différence.

Investir dans la santé réduit-il la prévalence de la dépression ?

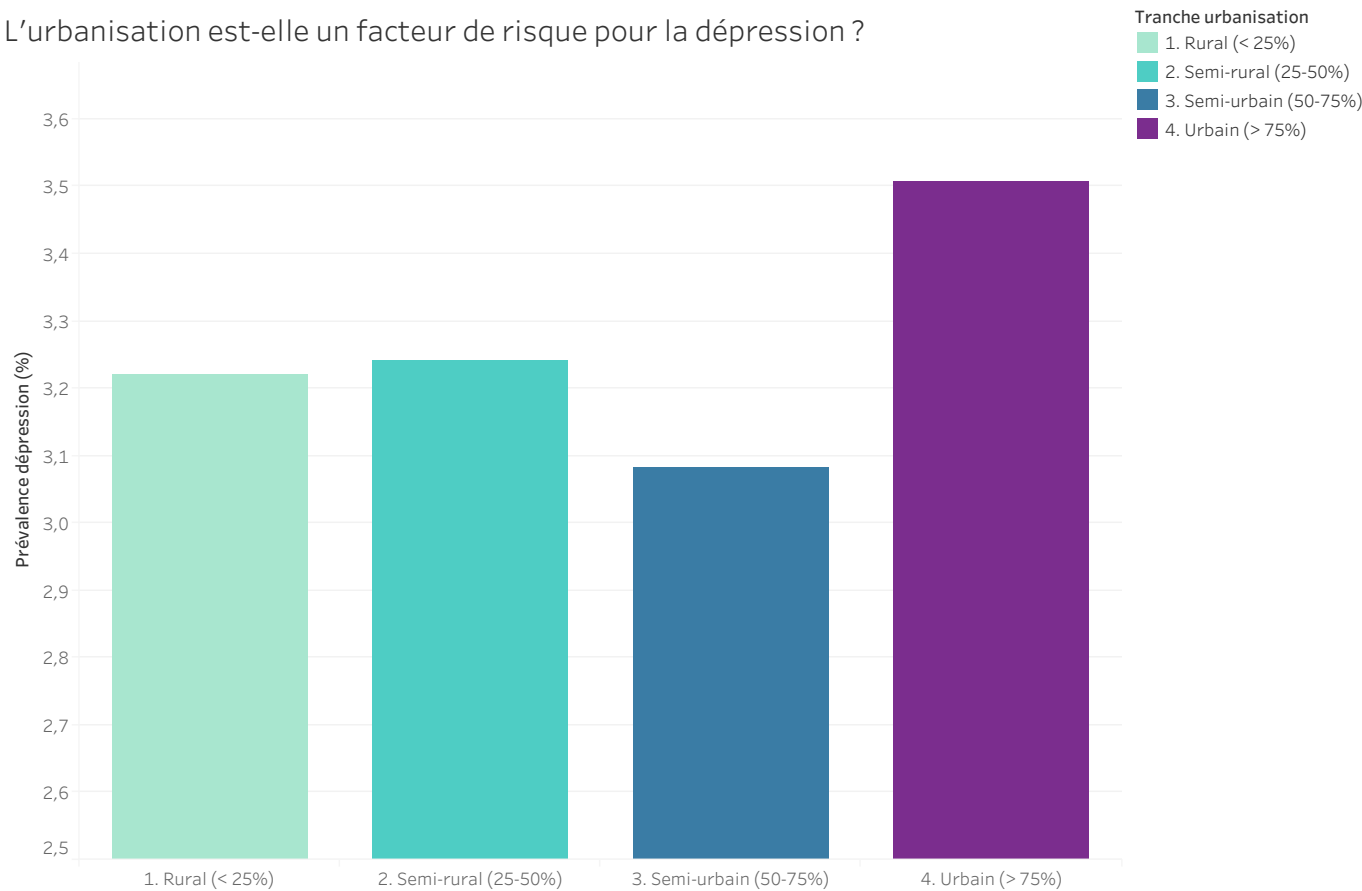


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 2 - Écart homme/femme	Axe 2 - Inégalité de genre et diagnostic	Axe 3 - Dépenses de santé	Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle	Axe 4 - Impact du COVID par genre	Axe 4 - Impact du COVID par continent
---------------------------	--	---------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Les pays les plus urbanisés (>75 % de population urbaine) affichent une prévalence légèrement plus élevée. Attention cependant : l'axe Y commence à 2,5 % et non à 0, ce qui amplifie visuellement les différences. L'effet de l'urbanisation existe mais reste modeste.

L'urbanisation est-elle un facteur de risque pour la dépression ?



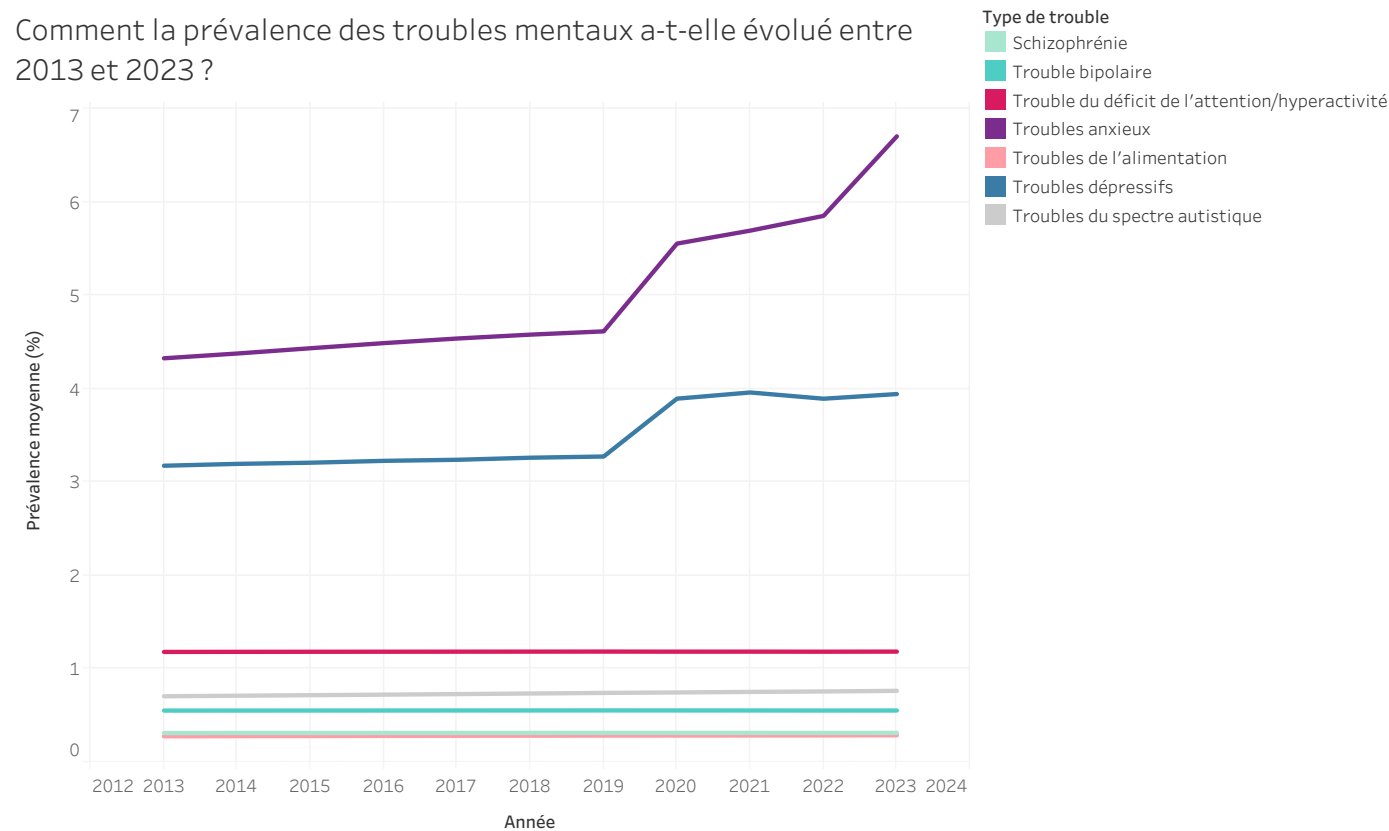
La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 2 - Inégalité de genre et diag..	Axe 3 - Dépenses de santé	Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle	Axe 4 - Impact du COVID par genre	Axe 4 - Impact du COVID par continent	Focus - Troubles alimentaires
--------------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Entre 2013 et 2019, la prévalence restait stable. Le COVID-19 a provoqué un bond brutal de l’anxiété, qui continue d’augmenter même après la pandémie. La dépression, elle, a augmenté puis s’est stabilisée.

Cette différence de trajectoire pourrait s’expliquer par un contexte post-COVID anxiogène persistant : multiplication des conflits internationaux, urgence climatique, montée de l’incertitude économique, et omniprésence médiatique qui amplifie les inquiétudes. L’anxiété, en tant que réaction à l’incertitude, continue d’être alimentée par ces facteurs, tandis que la dépression, plus liée à l’isolement du confinement, s’est stabilisée avec le retour à la vie normale.

Comment la prévalence des troubles mentaux a-t-elle évolué entre 2013 et 2023 ?

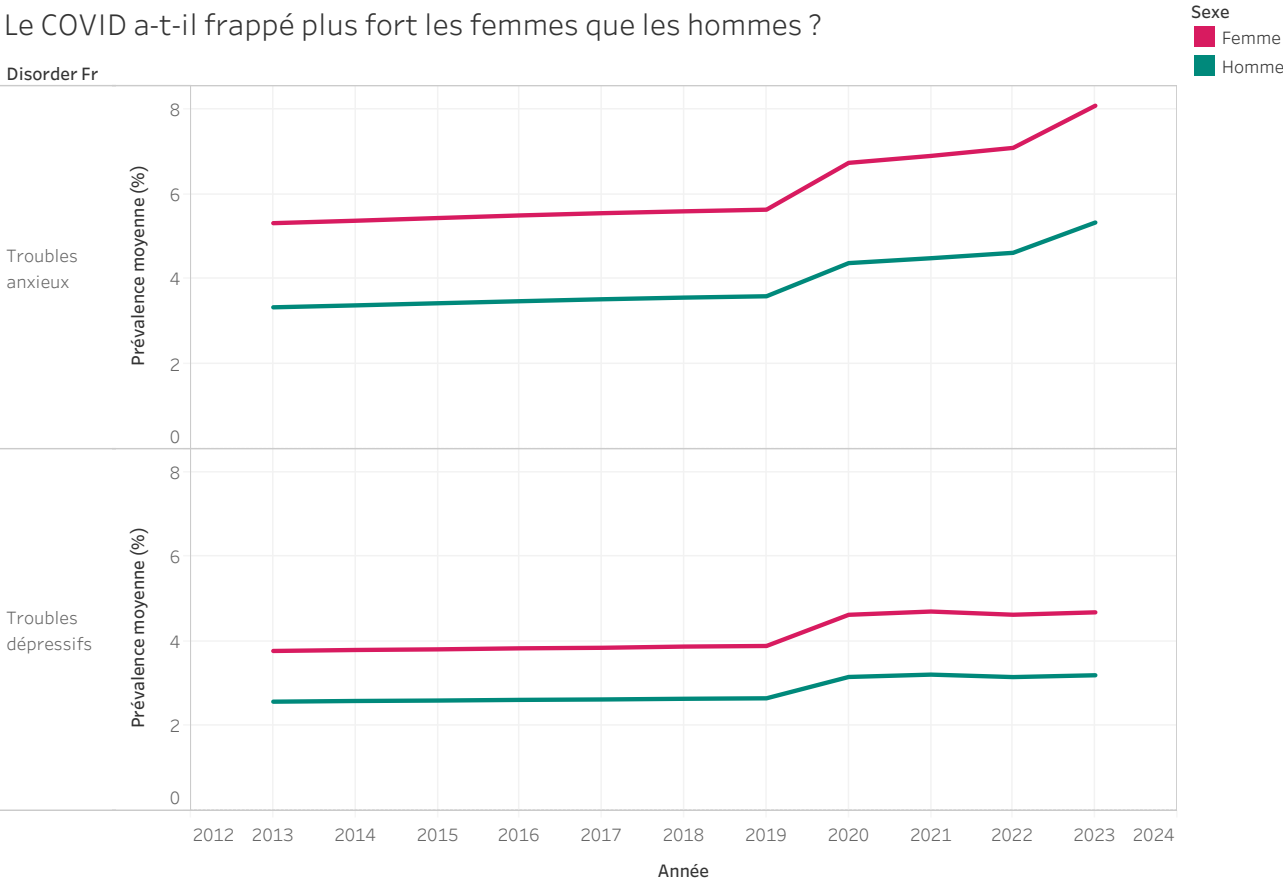


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 3 - Dépenses de santé	Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle	Axe 4 - Impact du COVID par genre	Axe 4 - Impact du COVID par continent	Focus - Troubles alimentaires	Conclusion
---------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------

Les femmes restent systématiquement plus touchées que les hommes, aussi bien pour l’anxiété que pour la dépression. Après 2020, les deux sexes ont connu une hausse à peu près similaire. Le COVID a amplifié un problème déjà existant, sans modifier la structure des inégalités de genre.

Le COVID a-t-il frappé plus fort les femmes que les hommes ?

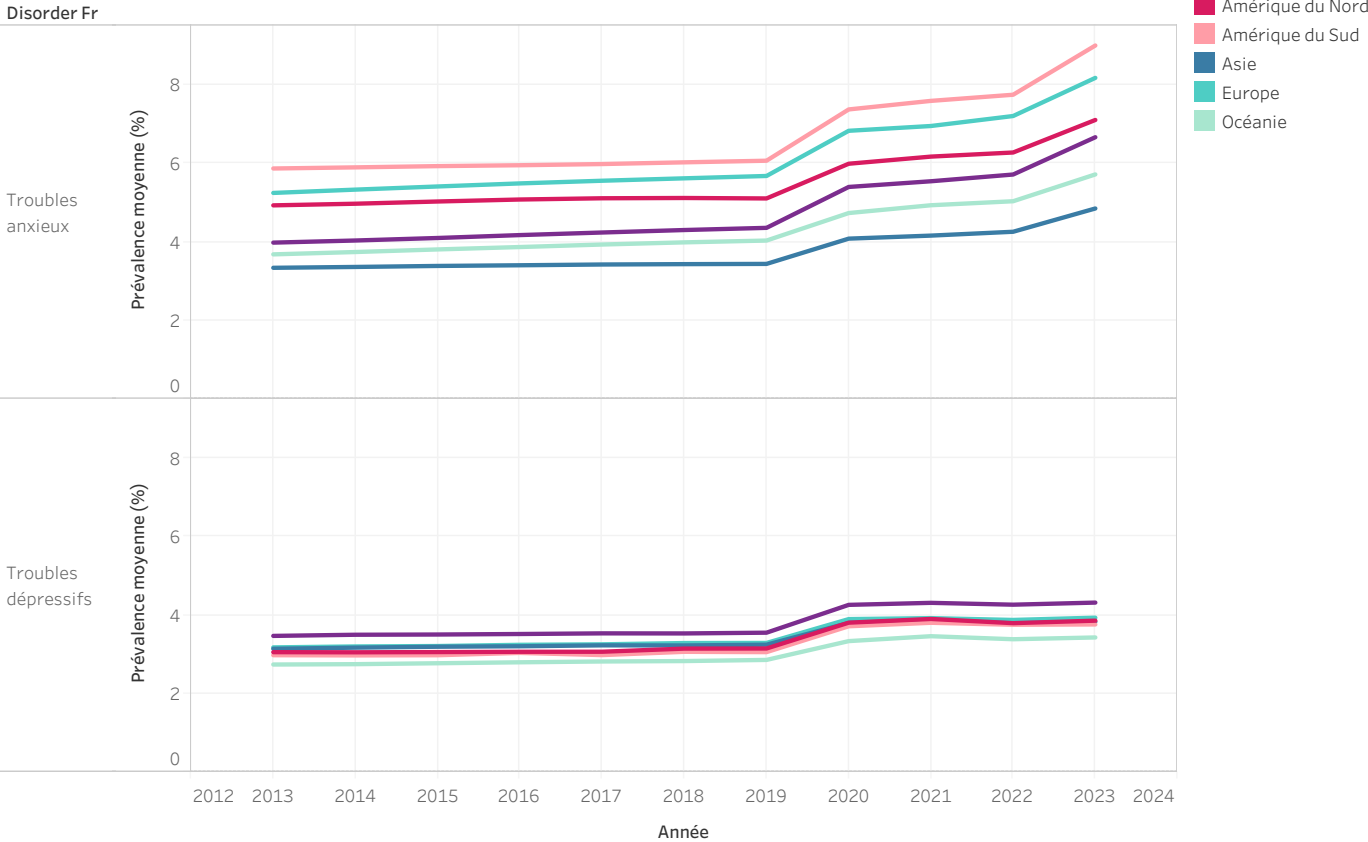


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle	Axe 4 - Impact du COVID par genre	Axe 4 - Impact du COVID par continent	Focus - Troubles alimentaires	Conclusion	Limites biais
----------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------	---------------

Les dynamiques varient selon le trouble. Pour l’anxiété, l’Amérique du Nord et l’Europe dominent, avec une forte accélération post-COVID en Amérique du Sud. Pour la dépression, c’est l’Afrique qui se démarque nettement, possiblement en raison de facteurs liés à l’instabilité et la pauvreté. L’Océanie affiche les taux de dépression les plus bas.

Le COVID n’a pas frappé tous les continents de la même manière

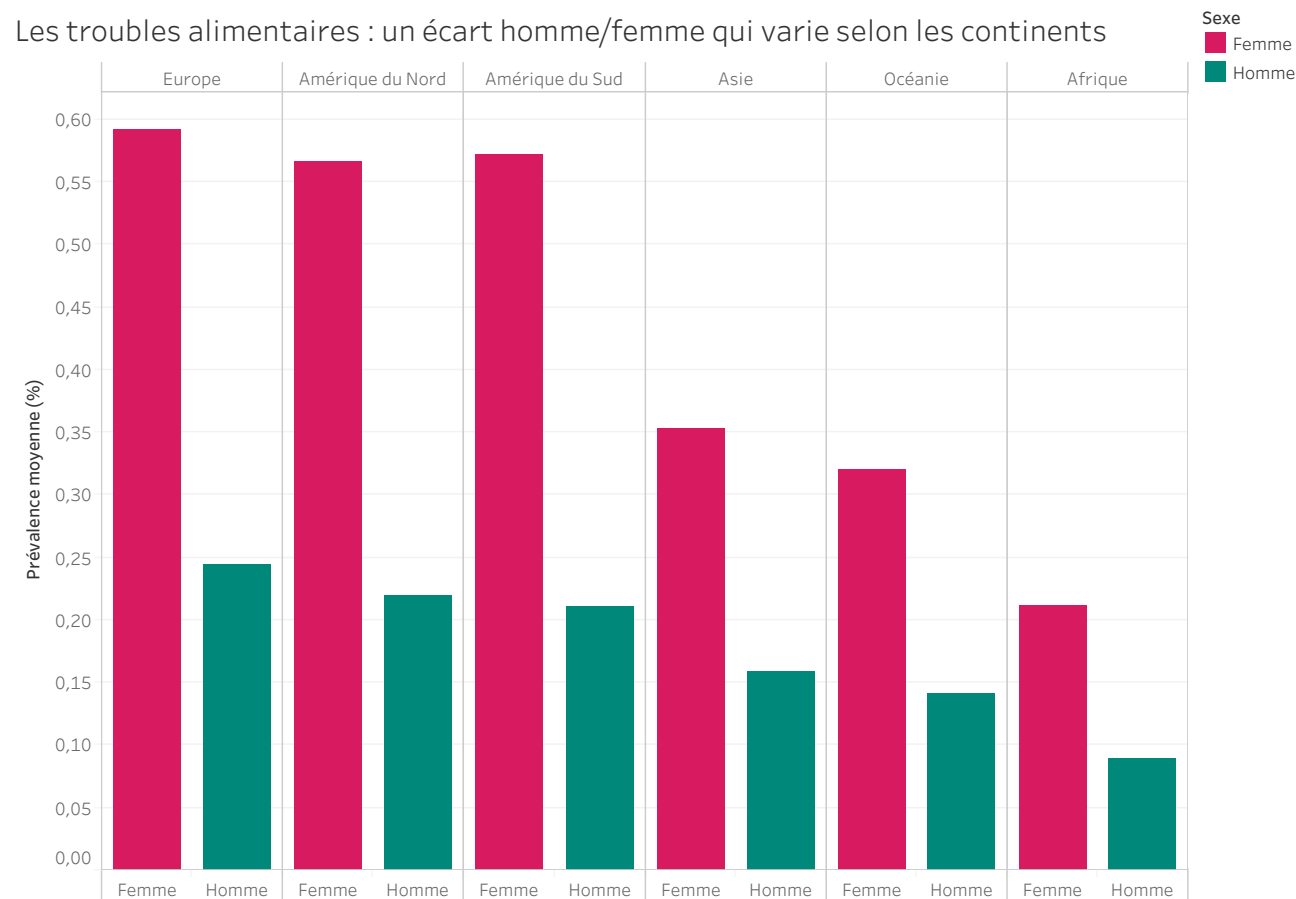


La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle	Axe 4 - Impact du COVID par genre	Axe 4 - Impact du COVID par continent	Focus - Troubles alimentaires	Conclusion	Limites biais
----------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------	---------------

Nous avons vu que le genre joue un rôle majeur dans la prévalence des troubles mentaux. Ce constat est particulièrement frappant pour les troubles alimentaires : les femmes sont systématiquement plus touchées sur tous les continents. L'Europe affiche la prévalence la plus élevée et l'écart homme/femme le plus marqué, tandis que l'Afrique présente les taux les plus bas, probablement en raison d'un sous-diagnostic : un schéma que l'on retrouve dans l'ensemble de notre analyse.

Les troubles alimentaires : un écart homme/femme qui varie selon les continents



La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle	Axe 4 - Impact du COVID par genre	Axe 4 - Impact du COVID par continent	Focus - Troubles alimentaires	Conclusion	Limites biais
----------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------	---------------

La santé mentale est un enjeu universel qui touche plus de 10% de la population mondiale. À travers l’exploration de 204 pays sur 11 ans, quatre enseignements majeurs se dégagent :

La richesse ne protège pas, elle révèle. Les pays riches et développés affichent des taux de dépression plus élevés, non pas parce que leurs populations souffrent davantage, mais parce qu’elles sont mieux diagnostiquées. Les médianes de prévalence restent proches quel que soit le niveau de revenu, mais la variabilité est bien plus grande parmi les pays riches.

Le genre amplifie les inégalités. Les femmes sont presque deux fois plus touchées par l’anxiété et la dépression. Dans les pays les plus inégalitaires, cet écart disparaît : non pas parce que les femmes vont mieux, mais parce qu’elles n’ont pas accès au diagnostic. Les troubles alimentaires illustrent aussi ce phénomène : l’Europe affiche l’écart le plus marqué, l’Afrique le plus faible.

Le COVID-19 a agi comme un accélérateur. La pandémie a provoqué une hausse brutale des troubles anxieux, bien plus que de la dépression. L’anxiété, réaction immédiate au stress, a bondi là où la dépression a augmenté plus modérément. L’Amérique et l’Europe affichent les prévalences d’anxiété les plus élevées, tandis que pour la dépression, c’est l’Afrique qui se démarque nettement, possiblement en lien avec l’instabilité et la pauvreté. L’Océanie présente les taux de dépression les plus bas.

Les dépenses de santé ne suffisent pas. Le volume des investissements n’a pas d’effet clair sur la prévalence. C’est la qualité et le ciblage vers la santé mentale qui feront la différence.

La santé mentale à travers le monde : une analyse en données

Axe 3 - Urbanisation	Axe 4 - Évolution temporelle	Axe 4 - Impact du COVID par genre	Axe 4 - Impact du COVID par continent	Focus - Troubles alimentaires	Conclusion	Limites biais
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------	---------------

Limites et biais à prendre en compte :

Les données de prévalence dépendent fortement des capacités de diagnostic de chaque pays. Les pays à faible revenu ou à faible développement humain sous-estiment probablement la réalité.

Les corrélations observées ne sont pas des causalités : un PIB élevé ne cause pas la dépression, il favorise sa détection.

Enfin, certaines visualisations (comme l’axe Y tronqué pour l’urbanisation) amplifient visuellement des différences modestes : un choix assumé mais à garder en tête.

Derrière chaque chiffre, des millions de personnes attendent un meilleur accès au diagnostic et aux soins.